

Praktijknaam



● Protocol: zorgtraject diabetes

Doelgroep

Patiënten met diabetes type 2 die voldoen aan de voorwaarden voor het zorgtraject

Verantwoordelijke:

Laurent

Laatste herziening:

17/02/2025

Volgende herziening:

17/02/2025

Intern zorgteam

- Huisarts
- Diëtist(e)
- Verpleegkundige
- Onthaal

Inhoudsopgave

Het protocol

1. Steekkaart	2
2. Maand 0: Contactmoment 1-A: fysiek	3
3. Maand 3: Contactmoment 2-A: fysiek	5
4. Maand 6: Contactmoment 3-1: Fysiek	7
5. Maand 9: Contactmoment 4-1: Fysiek	9
6. Populatie-Streefdoelen	11
7. Logboek.....	12
8. Bronnen.....	13

Projectmanagement van dit protocol

1. De noodzaak	14
2. De doelstelling	14
3. De doelgroep.....	14
3.1 Beschrijving van de doelgroep	14
4. Inclusie in het protocol.....	15
5. Visie op de rolbeschrijving binnen de context van dit protocol	15
6. Procesevaluatie van het protocol	16
7. Regionale zorgplannen/zorgsystemen: Zorgtraject diabetes type II	17

1. steekkaart

Fase van de consultatie	Verpleegkundige			Huisarts
	Maand 0	Maand 3	Maand 6	Maand 9
Anamnese	• Leefstijl (voeding, beweging) • Hypo-, hyperglycemie • Medicatie	• Leefstijl (voeding, beweging) • Mentaal welbevinden • Alcohol • Medicatie	• Leefstijl (voeding, beweging) • Rookgedrag • Seksueel functioneren • Medicatie	• Leefstijl (voeding, beweging) • Medicatie • Bespreek medische verslagen
Klinisch onderzoek/ actie	• HbA1C, glycemie • Bloeddruk, gewicht, buikomtrek	• HbA1C, glycemie, albumine • Bloeddruk, gewicht, buikomtrek • Vaccineer zo nodig	• HbA1C, glycemie, lipiden, eGFR • Bloeddruk, gewicht, buikomtrek • Voetonderzoek	• HbA1C, glycemie • Bloeddruk, gewicht, buikomtrek • Rijgeschiktheid (5-jaarlijks)
Planning	• Verwijs endocrinoloog • Herhaalvoorschriften • Teleconsult inplannen • Kwartaalcontrole inplannen • Urinepotje meegeven	• Bespreek verslag endocrinoloog • Vaccinatiestatus • Herhaalvoorschriften • Teleconsult inplannen • Kwartaalcontrole inplannen	• Herhaalvoorschriften • Verwijzing podoloog, specialist • Teleconsult inplannen • Kwartaalcontrole inplannen	• Herhaalvoorschriften • Verlening attestaten zo nodig • Teleconsult inplannen • Kwartaalcontrole inplannen
Telefonisch opvolgcontact	• Labo bespreken • Zorgplan aanpassen zo nodig • Herhaal afspraken	• Labo bespreken • Zorgplan aanpassen zo nodig • Herhaal afspraken	• Labo bespreken • Zorgplan aanpassen zo nodig • Herhaal afspraken	Verpleegkundige
				• Labo bespreken • Zorgplan aanpassen zo nodig • Herhaal afspraken

2. Maand 0: Contactmoment 1-A: fysiek

Uitvoerder: Verpleegkundige		Contact type: Fysieke consultatie	
Fase in de consultatie	Actie	Interne communicatie (EMD-registratie, mail, overleg...)	Link naar procedure, website...
Anamnese	- Bevraag leefstijl van de laatste 3 maand (Voeding, beweging) - Educatie symptomen hypo-, hyperglycemie - Overloop medicatie - Pols naar verwachtingen labo-resultaat	Contact: subjectief	
Klinisch onderzoek/acties	- labo (HbA1C, nuchtere glycemie) - Bloeddruk - Gewicht - Buikomtrek	Contact: Objectief Contact: Acties Planning: afvinken	
Bespreking	- Bespreek bloeddruk en doelstelling (koppel zo nodig aan leefstijl) - Bespreek gewicht en doelstelling (koppel zo nodig aan leefstijl)	Planning: update zorgdoelen	
Planning	- Jaarlijkse verwijzing naar endocrinoloog - Herhaalvoorschriften geven - Telefonische consultatie plannen voor bespreken resultaten - Volgende kwartaal controle plannen - Urinepotje meegeven met instructie	Contact: medicatie Contact: planning Planning: afvinken	
Aandachtspunten/extra info: (herhaal)voorschriften worden via een taak naar de vaste huisarts gestuurd. Zo nodig wordt dit ondersteunt door een (telefonisch) overleg tussen de Huisarts en verpleegkundige. Huisarts maakt digitale voorschriften binnen 48u of verwittigt patiënt als er alsnog een wijziging gebeurt. - Volgende contactmomenten inplannen door zorgverlener of onthaalmedewerker. - Zaken in het paars zijn uniek aan dit contactmoment.			

Maand 0: Contactmoment 1-B: telefonisch

Uitvoerder: Verpleegkundige		Contact type: Telefonische consultatie	
Fase in de consultatie	Actie	Interne communicatie (EMD-registratie, mail, overleg...)	Link naar procedure, website...
Bespreking	• Meedelen labo-waarden	Contact: subjectief	
Anamnese	• Bij afwijkende resultaten: pols of de patiënt een idee heeft van de oorzaak • Vraag of er al een afspraak is bij de endocrinoloog	Contact: Objectief	
Bespreking	• Bespreek zo nodig aanpassingen aan het zorgplan	Contact: planning Planning: update zorgdoelen	
Planning	• Herhaal de datum en verwachtingen voor de volgende afspraak		
Aandachtspunten/extra info:			

3. Maand 3: Contactmoment 2-A: fysiek

Uitvoerder: Verpleegkundige		Contact type: Fysieke consultatie	
Fase in de consultatie	Actie	Interne communicatie (EMD-registratie, mail, overleg...)	Link naar procedure, website...
Anamnese	- Bevraag leefstijl van de laatste 3 maand (Voeding, beweging) - Bevraag mentaal welbevinden - Bespreek alcoholgebruik - Overloop medicatie - Pols naar verwachtingen labo-resultaat	Contact: subjectief	
Klinisch onderzoek/acties	- labo (HbA1C, nuchtere glycemie, micro-albuminurie) - Bloeddruk - Gewicht - Buikomtrek	Contact: Objectief Contact: Acties Planning: afvinken	
Bespreking	- Bespreek verslag van de endocrinoloog - Controleer vaccinatiestatus (en vaccineer z.n.) - Bespreek bloeddruk en doelstelling (koppel zo nodig aan leefstijl) - Bespreek gewicht en doelstelling (koppel zo nodig aan leefstijl)	Planning: update zorgdoelen	
Planning	- Verwijzing diëtist zo nodig - Herhaalvoorschriften geven - Telefonische consultatie plannen voor bespreken resultaten - Volgende kwartaal controle plannen	Contact: medicatie Contact: planning Planning: afvinken	
Aandachtspunten/extra info: (herhaal)voorschriften worden via een taak naar de vaste huisarts gestuurd. Zo nodig wordt dit ondersteunt door een (telefonisch) overleg tussen de Huisarts en verpleegkundige. Huisarts maakt digitale voorschriften binnen 48u of verwittigt patiënt als er alsnog een wijziging gebeurt. - Volgende contactmomenten inplannen door zorgverlener of onthaalmedewerker. - Zaken in het paars zijn uniek aan dit contactmoment.			

Maand 3: Contactmoment 2-B: telefonisch

Uitvoerder: Verpleegkundige		Contact type: Telefonische consultatie	
Fase in de consultatie	Actie	Interne communicatie (EMD-registratie, mail, overleg...)	Link naar procedure, website...
Bespreking	Meedelen labo-waarden	Contact: subjectief	
Anamnese	Bij afwijkende resultaten: pols of de patiënt een idee heeft van de oorzaak	Contact: Objectief	
Bespreking	Bespreek zo nodig aanpassingen aan het zorgplan	Contact: planning Planning: update zorgdoelen	
Planning	Herhaal de datum en verwachtingen voor de volgende afspraak		
Aandachtspunten/extra info:			

4. Maand 6: Contactmoment 3-1: Fysiek

Uitvoerder: Verpleegkundige		Contact type: Fysieke consultatie	
Fase in de consultatie	Actie	Interne communicatie (EMD-registratie, mail, overleg...)	Link naar procedure, website...
Anamnese	- Bevraag leefstijl van de laatste 3 maand (Voeding, beweging) - Bespreek rookgedrag - Bevraag seksuele klachten - Overloop medicatie - Pols naar verwachtingen labo-resultaat	Contact: subjectief	
Klinisch onderzoek/acties	- labo (HbA1C, nuchtere glycemie, lipiden, eGFR) - Bloeddruk - Gewicht - Buikomtrek - Voetonderzoek	Contact: Objectief Contact: Acties Planning: afvinken	
Bespreking	- Bespreek bloeddruk en doelstelling (koppel zo nodig aan leefstijl) - Bespreek gewicht en doelstelling (koppel zo nodig aan leefstijl)	Planning: update zorgdoelen	
Planning	- Telefonische consultatie plannen voor bespreken resultaten - Herhaalvoorschriften geven - Verwijzing naar podoloog zo nodig - Jaarlijkse verwijzing naar specialist zo nodig (cardioloog...) - Volgende kwartaal controle plannen bij de huisarts	Contact: medicatie Contact: planning Planning: afvinken	
Aandachtspunten/extra info: (herhaal)voorschriften worden via een taak naar de vaste huisarts gestuurd. Zo nodig wordt dit ondersteunt door een (telefonisch) overleg tussen de Huisarts en verpleegkundige. Huisarts maakt digitale voorschriften binnen 48u of verwittigt patiënt als er alsnog een wijziging gebeurt. - Volgende contactmomenten inplannen door zorgverlener of onthaalmedewerker. - Zaken in het paars zijn uniek aan dit contactmoment.			

Maand 6: Contactmoment 3-B: telefonisch

Uitvoerder: Verpleegkundige		Contact type: Telefonische consultatie	
Fase in de consultatie	Actie	Interne communicatie (EMD-registratie, mail, overleg...)	Link naar procedure, website...
Bespreking	Meedelen labo-waarden	Contact: subjectief	
Anamnese	- Bij afwijkende resultaten: pols of de patiënt een idee heeft van de oorzaak - Vraag of er al een afspraak is bij oftalmoloog (en specialist/podoloog zo nodig)	Contact: Objectief	
Bespreking	Bespreek zo nodig aanpassingen aan het zorgplan	Contact: planning Planning: update zorgdoelen	
Planning	Herhaal de datum en verwachtingen voor de volgende afspraak		
Aandachtspunten/extra info:			

5. Maand 9: Contactmoment 4-1: Fysiek

Uitvoerder: Huisarts		Contact type: Fysieke consultatie	
Fase in de consultatie	Actie	Interne communicatie (EMD-registratie, mail, overleg...)	Link naar procedure, website...
Anamnese	- Bevraag leefstijl van de laatste 3 maand (Voeding, beweging) - Overloop medicatie - Pols naar verwachtingen labo-resultaat	Contact: subjectief	
Klinisch onderzoek/acties	- labo (HbA1C, nuchtere glycemie) - Bloeddruk - Gewicht - Buikontrek - Rijgeschiktheid (5-jaarlijks)	Contact: Objectief Contact: Acties Planning: afvinken	
Bespreking	- Bespreek bloeddruk en doelstelling (koppel zo nodig aan leefstijl) - Bespreek gewicht en doelstelling (koppel zo nodig aan leefstijl) - Bespreek medische verslagen	Planning: update zorgdoelen	
Planning	- Telefonische consultatie plannen voor bespreken resultaten - Herhaalvoorschriften geven - Verlenging van attesten zo nodig - Volgende kwartaal controle plannen bij de verpleegkundige	Contact: medicatie Contact: planning Planning: afvinken	
Aandachtspunten/extra info: (herhaal)voorschriften worden via een taak naar de vaste huisarts gestuurd. Zo nodig wordt dit ondersteunt door een (telefonisch) overleg tussen de Huisarts en verpleegkundige. Huisarts maakt digitale voorschriften binnen 48u of verwittigt patiënt als er alsnog een wijziging gebeurt. - Volgende contactmomenten inplannen door zorgverlener of onthaalmedewerker. - Zaken in het paars zijn uniek aan dit contactmoment.			

Maand 9: Contactmoment 4-B: telefonisch

Uitvoerder: Verpleegkundige		Contact type: Telefonische consultatie	
Fase in de consultatie	Actie	Interne communicatie (EMD-registratie, mail, overleg...)	Link naar procedure, website...
Bespreking	Meedelen labo-waarden	Contact: subjectief	
Anamnese	Bij afwijkende resultaten: pols of de patiënt een idee heeft van de oorzaak	Contact: Objectief	
Bespreking	Bespreek zo nodig aanpassingen aan het zorgplan	Contact: planning Planning: update zorgdoelen	
Planning	Herhaal de datum en verwachtingen voor de volgende afspraak		
Aandachtspunten/extra info:			

6. Populatie-Streefdoelen

Het vooropstellen van **populatie-streefdoelen dient als ondersteuning** voor het bepalen van het gezondheidsbeleid maar kan ook gebruikt worden als kader waarin een verpleegkundige (of andere discipline) autonoom kan handelen. Het vooropstellen van **streefdoelen gebeurt echter op populatieniveau**. Tijdens een consultatie **op patiëntniveau dient men ook de persoonlijke doelstelling** van de patiënt in rekening te brengen, deze zijn niet altijd gelijk aan de vooropgestelde streefdoelen zoals je ze hieronder kan noteren. De **ICE van de patiënt is niet altijd gelijk aan de ICE van de zorgverlener**. **In onderstaande tabel zijn enkele voorbeeldwaarden ingevuld. Dit is ter illustratie, ga zelf op zoek naar de richtlijnen die van toepassing zijn op jouw doelgroep om de tabel correct in te vullen.**

Parameter		Streefdoel	Oranje vlag	Rode vlag	Link naar bron/procedure
Lichamelijk	Bloeddruk	SBP 120-129 mmHg DPB < 85 mmHg	SBP 130-139 DBP 86-89	SBP > 140 DBP > 90	2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension
	BMI	18 - 25			
	Buikomtrek	- Vrouw: 80-88 - Man: 94-102			
Labo	HbA1c	6,5% ALS < 65j of denovo 7% ALS > 65j of geen nieuwe diagnose 7,5% ALS 65j+ en 1 of 2 comorbiditeiten 8% ALS 65j+ en 3 comorbiditeiten en/of MCI of 2 IADL beperkingen 8,5% ALS 65j+ en palliatief of dementie of 2 ADL beperkingen of WZC	+ 0,5%	> + 1%	Formularium Ouderenzorg
	LDL	< 55 mg/dl ALS CVR very high risk < 70 mm/dl ALS CVR high risk < 100 mm/dl ALS CVR moderate risk			ehad192.pdf
	eGFR	Afhankelijk van comorbiditeiten	Daling van 5/j of 10/5j		
	Albumine in urine	- Vrouw: > 20 mg/gr. creatinine - Man: > 30 mg/gr. creatinine			

7. Logboek

Datum	Aanpassing(en)
17/02/2025	• Nieuwe figuur van het diabetes landschap toegevoegd • Toevoegen proces-streefdoelen voor protocollaire zorg
18/01/2024	Toevoegen telefonische contactmomenten aan protocol
6/02/2023	Update streefwaarden HbA1C a.d.h.v. ouderenformularium
Klik of tik om een datum in te voeren.	
Klik of tik om een datum in te voeren.	
Klik of tik om een datum in te voeren.	
Klik of tik om een datum in te voeren.	
Klik of tik om een datum in te voeren.	
Klik of tik om een datum in te voeren.	
Klik of tik om een datum in te voeren.	
Klik of tik om een datum in te voeren.	
Klik of tik om een datum in te voeren.	

8. Bronnen

Het protocol dat als voorbeeld/inspiratie werd gebruikt voor dit protocol		
Titel	Andere info (praktijknaam, locatie...)	Link naar het voorbeeldprotocol
Richtlijn diabetes Mellitus type 2	XXX	

Andere bronnen gebruikt voor dit protocol	Link naar de bron	Info die gebruikt werd in het protocol
BCFI: ouderenformularium	Formularium Ouderenzorg	HbA1C streefwaarden
ESC	ehad192.pdf	Lipiden streefwaarden
NHG	Diabetes mellitus type 2 NHG-Richtlijnen	Varia
Domus Medica	Diabetes Mellitus Type 2 Domus Medica	Varia

Projectmanagement van dit protocol

1. De noodzaak

Een belangrijk deel van onze patiënten hebben diabetes mellitus type II. Deze aandoening vraagt een uitgebreide zorgopvolging waarbij een kwalitatieve zorgcontinuïteit belangrijk is om verder progressie of complicaties te voorkomen. Om de nodige zorg te verlenen is het belangrijk om interdisciplinair samen te werken waarbij we steunen op de sterkte van elke discipline. Interdisciplinair samenwerken is echter een complexe uitdaging en vraagt een doordachte zorgorganisatie en duidelijke afspraken tussen de betrokken zorgverleners.

2. De doelstelling

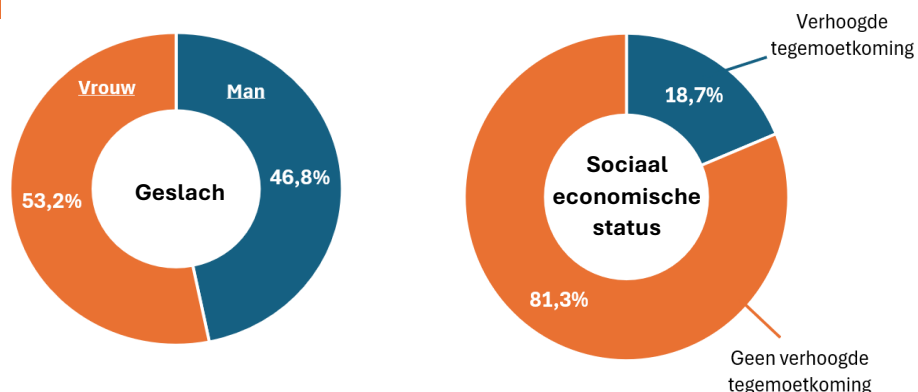
- Zorg verlenen aan patiënten die in overeenstemming is met de richtlijnen.
- Proactief bespreken en opvolgen van de leefstijl in functie van secundaire preventie.
- Proactieve opvolging van diabetes-parameters in functie van secundaire preventie.
- Organisatie van diabeteszorg op een interdisciplinaire manier.

3. De doelgroep

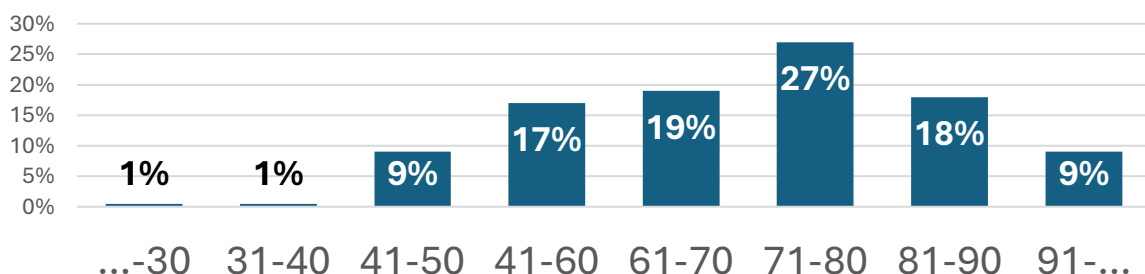
Patiënten met de diagnose 'diabetes mellitus type II' die voldoen aan de voorwaarden voor het zorgtraject.

3.1 Beschrijving van de doelgroep

Aantal: **378**



Patiëntenverdeling/leeftijdsgroep



4. Inclusie in het protocol

Het contract wordt altijd getekend door de vaste huisarts van de patiënt. Het bepalen of de patiënt voldoet aan de voorwaarden van het zorgtraject en dus in aanmerking komt om opgevolgd te worden via dit protocol kan op volgende manieren:

1. Vaststelling door externe zorgverlener (vb. specialist) waarna consultatie met de huisarts.
2. Vaststelling door de huisarts.
3. Vaststelling door de verpleegkundige, vb. door progressie van patiënt in het opstarttraject. Noodzaak van een consultatie bij de huisarts wordt in overleg bepaald.

5. Visie op de rolbeschrijving binnen de context van dit protocol

Elke zorgdiscipline kijkt naar de patiënt vanuit een eigen referentiekader, met een eigen set aan competenties en ervaringen. Als praktijk geloven we erin dat het resultaat van interdisciplinair samenwerken groter is dan de som der delen ($1+1=3$).

Interdisciplinair samenwerken betekent voor ons gelijkwaardigheid tussen disciplines, dit kan enkel bereikt worden als iedereen verantwoordelijkheid kan, mag en wil nemen met betrekking tot het verlenen van patiëntenzorg. In onze praktijk vertaalt dit zich naar zorgprofessionals die autonoom mogen handelen binnen de grenzen van hun bevoegdheden en bekwaamheden.

Discipline	Rol en verantwoordelijkheden
Huisarts	• Superviserende rol • Adviserende rol waar nodig • Evalueert complexiteit van de casus en heeft de autonomie om het zorgbeleid hierop af te stemmen • Eindverantwoordelijke van de farmacologische therapie
Verpleegkundige	• Coördinerende rol • Evalueert de patiënt holistisch • Verantwoordelijk voor de niet-farmacologische therapie
Onthaal	• Triërende rol • Ondersteund zorgcontinuïteit door patiënten te informeren over hun zorgpad en de nodige afspraken in te plannen.
Diëtist(e)	• Ondersteunende rol door advies te geven waar nodig • Kan proactief de populatie screenen en gepast actie ondernemen • Kan verbeterende projecten opzetten

6. Procesevaluatie van het protocol

Een protocol is een hulpmiddel om de zorg in je praktijk op een efficiëntere, maar ook kwaliteitsvollere manier te organiseren. Uiteindelijk willen we dat onze patiënt gezonder is en/of de levenskwaliteit stijgt. Een van de manieren waarop we daar als huisartsenpraktijk invloed op kunnen hebben is door ervoor te zorgen dat een patiënt op een correcte manier wordt opgevolgd. Bij het maken van een protocol is het hiervoor zinvol om op voorhand al na te denken over bepaalde procesindicatoren die je wil bereiken. Dit fungeert niet enkel als gids bij het maken van het protocol maar is een hulpmiddel om te evalueren of je met het protocol de beoogde doelstellingen bereikt. Wat de procesindicatoren zijn hangt af van het onderwerp van het protocol, hieronder alvast enkele voorbeelden:

- 4 keer/jaar HbA1C bepaling bij patiënten in het zorgtraject van diabetes
- 1 keer/jaar verwijzing naar diëtist(e) bij patiënten met hartfalen
- 2keer/jaar bloeddrukmeting bij patiënten met SBP>140

Indicator	Streefdoel	Basismeting	Resultaat	Opmerkingen	Link naar bron
% pt. met minstens 2 HbA1C metingen/jaar	75%	65%			
% pt. met minstens 1 urineonderzoek/jaar	75%	73%			
% pt. met minstens 2 bloeddrukmetingen/jaar	75%	87%			
% pt. <65j en HbA1C < 7%	75%	62%			
% pt. met verslag endocrinoloog < 1j geleden	75%	66%			

7. Regionale zorgplannen/zorgsystemen: Zorgtraject diabetes type II

Voor wie?

Diagnose Diabetes mellitus type II

+ behandeling met GLP-1-analoog OF 1 of 2 insuline-injecties/dag OF maximale orale diabetesmedicatie

+ Een GMD hebben waarin volgende parameters worden geregistreerd: BMI, BD, HbA1C, LDL-C

Hoe aanvragen?

Er wordt een contract ondertekent door de huisarts, endocrinoloog en patiënt. De patiënt bezorgt dit contract aan de mutualiteit. Het traject wordt jaarlijks automatisch verlengd zolang de voorwaarden voldaan blijven.

Verplichtingen voor de patiënt

- Jaarlijkse controle bij de endocrinoloog
- Minstens 2/jaar naar de huisarts gaan

Recht op begeleiding

- 5 educatiesessies/jaar gegeven door een diabeteseducator (volledig terugbetaald)
- 5 extra educatiesessies in jaar van opstart of kalenderjaar daaropvolgend (volledig terugbetaald)
- 2 x 30 minuten/jaar bij erkend diëtist (volledig terugbetaald)
- 2 x 45 minuten/jaar bij erkend podoloog (volledig terugbetaald bij verhoogd voetrisico)
- 1/jaar preventieve mondzorg (volledig terugbetaald)

Zelfcontrole materiaal

Bij behandeling met inspuiting of GLP-1-anaoog (ook oraal)

- Bloedglucosemeter/3 jaar
- 150 strips/6 maand
- 100 lancetten/6 maand

